Árbol de decisión — Cadera

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Cadera. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b. El porqué de cada paso, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 1232113f

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

1 ¿El dolor podría ser referido desde la columna lumbar o la articulación sacroilíaca?

SÍ
SACROILÍACA: señala con el dedo el dolor inferomedial a la EIPS (no solo en la línea media ni por encima de L5) y 3 o más de 5 tests de provocación positivos
→ 10 Dolor Articular Sacroilíaco

SÍ
LUMBAR: el dolor cambia con movimientos repetidos de la espalda, o la elevación de la pierna recta o el slump reproducen su dolor
→ sin hipótesis

NO
Origen coxofemoral: la cojera (unas 7 veces) y la rotación interna limitada (unas 14 veces) orientan más a la cadera que a la columna
→ sin hipótesis

todas

1b ¿Hay un evento desencadenante concreto y reciente (chut, sprint, cambio de dirección, estiramiento)?

SÍ
LESIÓN AGUDA: palpar primero; luego resistencia y estiramiento
→ 11 Lesión Aguda de Ingle

NO
Sin evento desencadenante concreto
→ sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 2 ↓

↓ Paso 2: viene del paso 1b

2 ¿El perfil es degenerativo (edad ≥45 años, rigidez matutina breve)?

SÍ
Edad ≥45 años, rigidez matutina <1 hora, rotación interna <24°
→ 1 Artrosis de Cadera

NO
Paciente joven/activo con síntomas mecánicos
→ sin hipótesis

todas

3 ¿Sospecha de origen intraarticular: dolor inguinal ligado al movimiento con FADDIR o flexión-RI positivos? Estos tests descartan; positivos no confirman.

SÍ
Compatible con pinzamiento femoroacetabular (SIFA), sin confirmar: seguir con Thomas
→ 2 Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular (SIFA)
→ desvío 3b

SÍ, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo
Posible desgarro labral
→ 2 Síndrome de Pinzamiento Femoroacetabular (SIFA)
→ 3 Desgarro del Labrum Acetabular
→ desvío 3b

NO
FADDIR y flexión-RI negativos: origen intraarticular improbable
→ sin hipótesis

NO EXPLORADO
FADDIR y flexión-RI no realizados (contraindicados o no tolerados): origen intraarticular sin valorar
→ sin hipótesis

NO / NO EXPLORADO → sigue en el paso 4, en la página siguiente →

SÍ / SÍ, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo

Desvío desde el paso 3 si «SÍ» o «SÍ, con chasquido doloroso, bloqueo o fallo»

3b ¿Thomas positivo con historia compatible (signo de la «C», síntomas mecánicos)? Identificar la entidad; pueden coexistir.

INESTABILIDAD / LIGAMENTO REDONDO →
12 Ligamento Redondo e Inestabilidad

CONDROPATÍA → 13 Condropatía de Cadera

ARTROSIS → 1 Artrosis de Cadera

FAIS / LABRUM → sin hipótesis

NO CONCLUYENTE → sin hipótesis

→ sigue en el paso 4

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de cadera inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

↓ Paso 4: viene del paso 3 o del 3b

4 ¿El dolor se localiza en la CARA EXTERNA de la cadera (trocánter mayor)?

- **SÍ** — Sensibilidad en trocánter mayor y dolor en apoyo monopodal <30s → **4 Síndrome de Dolor Trocantérico Mayor (Tendinopatía Glútea)**
- **SÍ** — Con marcha de Trendelenburg o debilidad medida en abductores → **5 Debilidad de Abductores de Cadera**
- **SÍ** — Calidad deficiente en sentadilla monopodal o step-down → **6 Disfunción de Control Neuromuscular de Cadera**
- **NO** — Sin dolor lateral → sin hipótesis

todas →

5 ¿El dolor se localiza en el GLÚTEO o zona isquiática?

- **Dolor profundo en glúteo que empeora al sentarse (ciática)** — posible Síndrome Piriforme → **7 Síndrome Glúteo Profundo (Síndrome Piriforme)**
- **Dolor que empeora con zancada larga al caminar** — posible Pinzamiento Isquiofemoral → **8 Pinzamiento Isquiofemoral**
- **Sensibilidad sobre tuberosidad isquiática** — posible Tendinopatía Proximal Isquiotibiales → **9 Tendinopatía Proximal de Isquiotibiales**
- **Sin localización clara posterior** → sin hipótesis

Todas → sigue en el paso 6 ↓

↓ Paso 6: viene del paso 5

6 ¿Qué reproduce su dolor conocido en la INGLE? Palpar primero y con precisión: las estructuras se solapan.

- **ADUCTOR** — Palpación dolorosa de aductores + squeeze doloroso → **16 Dolor Inguinal Relacionado con el Aductor**
- **PSOAS ILÍACO** — Palpación dolorosa supra o infrainguinal → **17 Dolor Inguinal Relacionado con el Psoas Ilíaco**
- **INGUINAL** — Palpación dolorosa del canal sin hernia palpable (de pie y con tos) → **18 Dolor Inguinal Relacionado con el Canal Inguinal**
- **PÚBICO** — Palpación dolorosa de la sínfisis y el hueso adyacente → **19 Dolor Inguinal Relacionado con el Pubis**
- **NINGUNO** — Sin dolor inguinal o nada lo reproduce → sin hipótesis

todas →

7 ¿Hay un patrón neuropático, o nada encaja y el dolor es extenso?

- **MERALGIA** — Tinel bajo la EIAS, parestesias anterolaterales del muslo → **14 Neuropatías de Cadera e Ingle**
- **OBTURADOR** — Dolor en ingle y muslo medial con el ejercicio → **14 Neuropatías de Cadera e Ingle**
- **ILIOINGUINAL, ILIOHIPOGÁSTRICO O GENITOFEMORAL** — Arch and twist de pie → **14 Neuropatías de Cadera e Ingle**
- **PUDENDO** — Dolor perineal al sentarse o en bici, sin déficit sensitivo objetivo → **14 Neuropatías de Cadera e Ingle**
- **SENSIBILIZACIÓN CENTRAL** — Nada encaja o dolor extenso (revisar banderas rojas) → **15 Sensibilización Central**
- **NINGUNO** — Sin patrón neuropático ni dolor extenso → sin hipótesis

Pregunta · Hipótesis que activa · Derivación (el recorrido sigue) · Sin hipótesis

Sin ninguna hipótesis al final: dolor de cadera inespecífico; revisar psicosociales y respuestas. **Fase 4b:** confirmar cada hipótesis con sus tests.

Generado desde los datos de la app el 31/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0